

Тестовое задание для Бизнес-Аналитика + Project менеджера для проекта «Цифровой помощник Тьютора»

Задача 1. Списки ключевых вопросов.

Вопросы отбирались по трём критериям:

1. Влияние на архитектуру решения и границы пилота: если ответ неизвестен, проектирование ведётся вслепую.
2. Влияние на принятие продукта пользователями: система, неудобная тьютору или непонятная родителям, не будет использоваться, как бы хорошо ни был написан код.
3. Юридические и этические ограничения: проект работает с чувствительными данными несовершеннолетних пациентов, поэтому вопросы согласий и доступа выделены в приоритет.

Формулировки открытые — они приглашают собеседника рассказать о реальной практике, а не подтвердить готовую догадку.

1.1 К Заказчику (Руководству организации)

Руководство организации определяет цели проекта, бюджет, юридические условия и состав пилотной группы со стороны Заказчика. Ответы этой группы задают рамку для всех остальных интервью: без понимания критериев успеха и ограничений по данным невозможно ни спроектировать систему, ни оценить результат пилота.

	Вопрос	Зачем спрашиваем	Какой риск закрывается
1	Какие бизнес-цели и измеримые критерии успеха сервиса вы считаете ключевыми?	Зафиксировать метрики до старта (доля заполненных дней, скорость корректировок ИОМ, удовлетворённость команды)	Продукт формально готов, но не принят: цели команды и заказчика не совпали
2	Кто со стороны заказчика является лицом принимающим решения и сколько времени готов уделять пилоту?	Определить цепочку согласований и допустимый темп утверждения решений	Размытая ответственность и длинные согласования срывают двухмесячный срок пилота
3	Какие требования законодательства и внутренней политики применяются к персональным данным пациентов (в том числе 152-ФЗ)?	Спроектировать контур хранения и обработки данных до создания базы данных	Юридическая блокировка пилота или утечка чувствительных данных
4	Сколько пациентов, тьюторов и специалистов охватывает пилот и кто отбирает участников?	Согласовать объём выборки, нагрузку на систему и критерии отбора	Нерепрезентативная выборка: выводы сервиса нельзя переносить на масштаб
5	Какие системы учёта используются сейчас и что должно быть интегрировано или замещено?	Выявить существующий ландшафт: таблицы, электронные журналы, мессенджеры	Дублирование ввода данных в старые и новые формы — сопротивление пользователей
6	Каков бюджет проекта и горизонт принятия решения о масштабировании после пилота? Нужно ли закладывать перспективы развития?	Заложить архитектурный запас и план передачи системы заранее	После пилота решение о развитии принимается внезапно, команда к нему не готова
7	Какие согласия от родителей (законных представителей) потребуются и кто отвечает за их оформление?	Встроить юридическую процедуру в план подготовки пилота	Старт пилота задерживается из-за отсутствия оформленных согласий

1.2 К Тьюторам

Тьюторы — источник всех данных в системе: без их ежедневного ввода решение не работает в принципе. Вопросы этой группы проверяют три вещи: реалистичность регламента ввода, совпадение шаблона с существующей практикой и личную ценность системы для самого тьютора.

	Вопрос	Зачем спрашиваем	Какой риск закрывается
1	Что мешает сегодняшним отчётам быть полезными для вас самих?	Найти точки личной ценности тьютора, а не только команды сопровождения	Тьютор не видит пользы для себя — дисциплина ввода падает
2	Какая обратная связь от системы была бы полезна вам в работе: динамика, напоминания, подсказки?	Встроить личную ценность в интерфейс тьютора с первого релиза	Односторонний поток «данные наверх» без отдачи — система воспринимается как контроль
3	Что вы записываете ежедневно и в какой момент дня?	Спроектировать форму и сценарий	Форма не впишется в работу. Поля не совпадают с реальностью - сбор ненужных данных.
4	Какие поля обязательны, а какие применимы не к каждому ребёнку? Требуется ли делать и загружать фото/видео(опция в перспективу)?	Сделать шаблон пригодным для разных случаев	Пустые или недостоверные записи
5	Как вы сегодня описываете эмоции, коммуникацию, поведение, питание, сенсорные реакции и сон?	Согласовать шкалы и словарь	Несопоставимые наблюдения
6	Сколько времени допустимо тратить на одну запись?	Установить требование к удобству	Тьюторы не будут пользоваться сервисом
7	Нужно ли сохранять черновик и исправлять запись после отправки?	Определить жизненный цикл записи	Потеря данных или отсутствие истории исправлений
8	Где вы работаете: компьютер, телефон, нестабильный интернет?	Выбрать интерфейс и технические ограничения	Решение недоступно в реальных условиях. Интерфейс недоступен в реальных условиях смены — ввод переносится «на потом» и теряется

1.3 К Специалистам сопровождения

Специалисты (психологи, дефектологи, логопеды) дополняют наблюдения тьюторов результатами занятий и принимают решения о корректировке ИОМ. Для них система полезна, если экономит время подготовки к занятию и делает подсказки проверяемыми.

	Вопрос	Зачем спрашиваем	Какой риск закрывается
1	Как вы сейчас фиксируете результаты занятий и кто их видит?	Понять смежный поток данных, который должен состыковаться с наблюдениями тьюторов	Разрыв «наблюдения — занятия»: профиль пациента остаётся неполным
2	Какие закономерности вы ищете в данных вручную сегодня?	Сформировать приоритетный список гипотез для AI-анализа	AI ищет не то, что реально нужно команде
3	Как устроен ИОМ: формат, периодичность пересмотра, кто принимает решения?	Встроить корректировку маршрута в процесс системы, а не рядом с ним	Подсказки не ведут к решениям — система не влияет на ИОМ
4	Какие данные о пациенте вам нужны к началу занятия и в каком виде?	Спроектировать «карточку перед занятием» в интерфейсе специалиста	Отчёты нерелевантны практике — специалисты возвращаются к своим заметкам
5	Что должно быть в AI-подсказке, чтобы вы могли на неё опереться?	Определить формат прозрачности: исходные данные, логика вывода, уровень уверенности	«Чёрный ящик»: специалисты игнорируют подсказки или оспаривают их вслепую
6	Какие показатели динамики пациента вы считаете значимыми?	Согласовать метрики визуализации профиля	Дашборды красивые, но клинически и педагогически пустые
7	Кто и как должен подтверждать корректность AI-выводов?	Определить роль «человека в контуре» при принятии решений	Автоматические рекомендации без ответственного — юридический и этический риск

1.4 К Родителям

Родители — источник согласий и главная аудитория прозрачности: именно им система должна показать динамику ребёнка понятным языком. Их ожидания нужно откалибровать до пилота, чтобы первое же расхождение реальности с ожиданиями не отвернуло семью от продукта.

	Вопрос	Зачем спрашиваем	Какой риск закрывается
1	Какую информацию о динамике ребёнка вы хотите получать и как часто?	Определить формат и периодичность отчётов для семьи	Ожидания не совпадают с тем, что показывает система: разочарование с первой недели
2	Какие формулировки показателей и графиков вам понятны?	Сделать отображение доступным	Неверное толкование данных
3	Готовы ли вы дать согласие на обработку данных ребёнка и какие категории данных вас беспокоят?	Получить юридическую базу пилота и настроить параметры приватности	Отказ в согласии сужает выборку или блокирует пилот
4	Что для вас означает «прозрачность» AI-выводов?	Спроектировать объяснимость подсказок на языке семьи, без жаргона	Недоверие к подсказкам и к системе в целом
5	Кто из круга семьи должен иметь доступ к профилю ребёнка?	Настроить ролевую модель доступа к данным	Семейные конфликты вокруг доступа к чувствительной информации
6	Что вы наблюдаете дома и хотели бы фиксировать сами?	Рассмотреть канал «наблюдения от семьи» в профиле пациента	Ценные данные о поведении ребёнка вне организации остаются вне системы
7	Как вы хотите получать срочную информацию — через систему или напрямую от специалистов?	Определить роль системы в критических ситуациях	Система воспринимается как единственный канал связи — риск при инцидентах

1.5 К Врачам

Врачи — самая требовательная аудитория к качеству и структуре данных: их решения опираются на клинически значимые признаки. Вопросы определяют формат выгрузок, границы медицинской интерпретации и требования к прослеживаемости записей.

	Вопрос	Зачем спрашиваем	Какой риск закрывается
1	Какие данные наблюдений и в какой структуре вам нужны для принятия решений?	Спроектировать отчёт и выгрузку для врача	Врачи не получают полезных данных — медицинский контур выпадает из системы
2	В каком формате удобно получать данные: сводка, графики, структурированная выгрузка?	Согласовать формат без перегрузки первичными записями	Данные существуют, но клинически не используются
3	Готовы ли вы оставлять интерпретации и заключения в системе?	Определить роль врача в контуре сопровождения	Медицинская экспертиза остаётся за пределами профиля пациента
4	Есть ли категории данных, которые нельзя обрабатывать или показывать в этом контуре?	Учесть границы медицинской этики и приватности	Нарушение этических норм и репутационные потери проекта
5	Какие изменения динамики для вас являются сигналом к действию?	Настроить пороги и правила эскалации AI-подсказок	Подсказки либо шумят, либо пропускают значимые изменения
6	Нужен ли вам доступ к первичным записям или достаточно агрегированных показателей?	Спроектировать уровни доступа для медицинского контура	Врач перегружен сырыми данными и перестаёт открывать систему
7	Что должно быть зафиксировано в записи наблюдения, чтобы вы могли на неё опереться?	Сформировать требования к качеству и прослеживаемости данных	Записи не признаются как основа для клинических решений

1.6 К Технической команде

Техническая команда отвечает за то, чтобы решение пережило пилот: поддерживалось, масштабировалось и не нарушало ограничений по безопасности. Вопросы к этой группе снимают риски неподдерживаемого стека, переусложнённой архитектуры и утечки данных.

	Вопрос	Зачем спрашиваем	Какой риск закрывается
1	Какой стек и инфраструктура уже используются у заказчика и что предпочтительно?	Выбрать технологии в рамках поддерживаемого ландшафта	Решение останется без сопровождения после окончания учебного проекта
2	Каковы нефункциональные требования: число пользователей, доступность, резервирование данных?	Откалибровать архитектуру MVP без переусложнения	Срыв сроков из-за избыточной архитектуры или отказ под нагрузкой пилота
3	Как устроен контур безопасности и разграничения доступа?	Встроить ролевую модель и журнал действий с первого дня	Утечка персональных данных пациентов
4	Какие готовые компоненты можно переиспользовать: СУБД, аутентификация, UI-наборы?	Не создавать существующее, сократить срок до MVP	Дублирование компонентов и лишние затраты
5	Кто будет сопровождать и развивать систему после пилота?	Заложить план передачи знаний и документации	«Осиротевшая» система: пилот прошёл, развивать некому
6	Как организованы релизный процесс и тестовые среды?	Вписаться в процесс поставки и тестирования заказчика	Дефекты доходят до тьюторов в разгар пилота
7	Допустимо ли использование внешних AI-сервисов или данные должны обрабатываться внутри контура?	Выбрать архитектуру AI-аналитики	Передача чувствительных данных наружу юридически невозможна — переделка на ходу

Задача 2. Описание ключевого бизнес-процесса.

В качестве ключевого для проекта выбран процесс «**Внесение и структурирование ежедневных наблюдений тьютором**». Именно он создаёт весь поток данных, на котором работают остальные сценарии: анализ динамики, подсказки, отчёты для родителей и врачей. Если этот процесс ненадёжен — данные неполны или неструктурированные, — все downstream-функции теряют смысл.

Пошаговое описание процесса

1. Тьютор открывает веб-интерфейс или мобильное приложение в начале рабочей смены. Система показывает список закреплённых пациентов или предлагает найти, а так же состояние имеющихся/незавершенных записей за сегодня.
2. Тьютор заполняет единую форму наблюдений по шаблону: выбор значений по шести категориям (эмоции, коммуникация, поведение, питание, сенсорика, сон) и необязательный комментарий свободным текстом. Форма спроектирована на заполнение за определенное время (напр. 5-7 минут)
3. Тьютор отправляет запись. До отправки он может вернуться к любому разделу формы; после отправки исправления вносятся отдельной корректирующей записью с сохранением истории.
4. Система валидирует запись: проверяет обязательные поля, допустимые значения и соответствие формату. При ошибке запись возвращается тьютору на исправление с указанием причины.
5. Бэкенд сохраняет валидную запись в базу данных: присваивает уникальный идентификатор, привязывает её к профилю пациента и автору, фиксирует дату и время.
6. Система структурирует данные: разносит значения по категориям профиля и обновляет агрегированные показатели динамики пациента.

Возможно, AI учувствует в структуризации: Пример. Тьютор вводит: «Плохо спал, около 5 часов. После обеда громко кричал и ударил себя несколько раз. От еды отказался». Система сохраняет исходный текст без изменения и отдельно получает структуру: сон — 5 часов; поведение — крик, эпизод самоагрессии; питание — отказ; период — после обеда. Здесь принципиально разделить три слоя: исходное наблюдение человека → извлечённые AI/алгоритмами факты → интерпретация/аналитическая подсказка. Они не должны незаметно подменять друг друга.

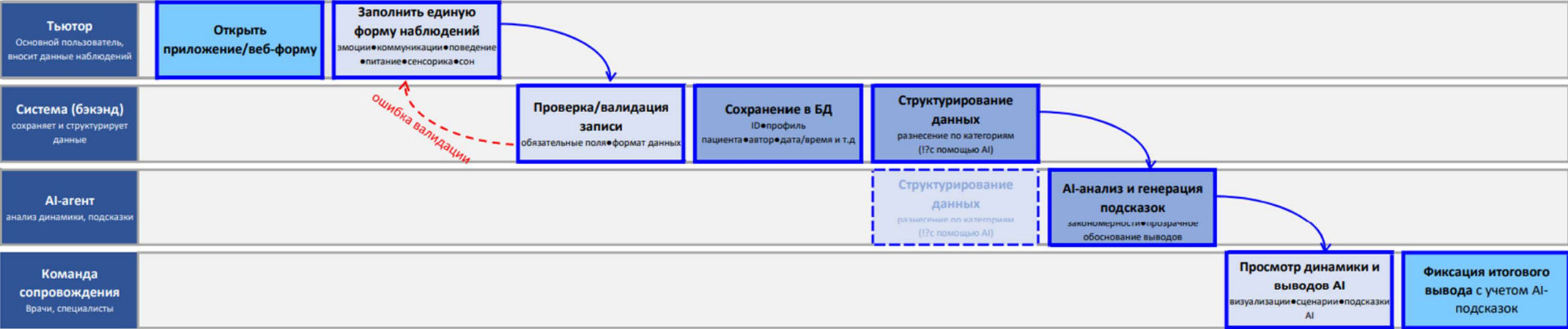
*Если AI не уверен в распознавании, система либо помечает соответствующее поле как требующее проверки, либо предлагает тьютору подтвердить вариант. Исправление AI-структуры не изменяет оригинальный текст. Для аудита хранятся автор, время, изменения и источник. Это позволяет позднее показать специалисту не просто вывод AI, а **evidence trail**: из каких наблюдений он получен.*

7. AI-агент анализирует накопленную динамику и выявляет повторяющиеся связи — например, «недосып усиливает агрессивные реакции» — по заранее согласованным с командой гипотезам.
8. AI-агент формирует подсказку для команды сопровождения с прозрачным обоснованием: какие записи легли в основу вывода, какова логика связи и уровень уверенности. Подсказку видит только команда сопровождения и врачи, тьюторы.
9. Специалисты и (возможно) родители (в рамках своих прав доступа) видят обновлённую динамику в профиле пациента: графики, события, подсказки с обоснованиями.
10. Команда принимает решение о корректировке ИОМ; решение и его основание фиксируются в системе, что замыкает цикл «наблюдение — анализ — действие».

Схема процесса (BPMN)

BPMN-схема: внесение и структурирование ежедневных наблюдений

Дорожки ролей: тьютор→система(бэкэнд)→AI-агент→команда сопровождения



Легенда:

начало/завершение

шаг процесса

ключевой процесс

→ потоки управления

- - - - - возврат по ошибке ввода

Задача 3. Дорожная карта пилота.

Пилот рассчитан на два месяца (восемь недель) и предлагает проверить три гипотезы.

1. Гипотеза принятия: тьюторы готовы ежедневно вносить наблюдения по единому шаблону, не увеличивая нагрузку сверх согласованного регламента.
2. Гипотеза ценности: структурированные данные дают команде сопровождения видимую динамику, которую не давали разрозненные записи.
3. Гипотеза доверия: прозрачные AI-подсказки с обоснованием принимаются специалистами и используются при корректировке ИОМ.

Предположим, **границы пилота**: два пациента с согласия родителей, два-три тьютора-тестера, одна группа специалистов и один врач-консультант. Внешние интеграции на период пилота исключаются — данные содержатся в контуре заказчика.

Целевые ориентиры успеха: не менее 80 процентов дней наблюдений содержат записи; не менее 90 процентов записей полностью заполнены; хотя бы одна корректировка ИОМ опирается на подсказку системы;

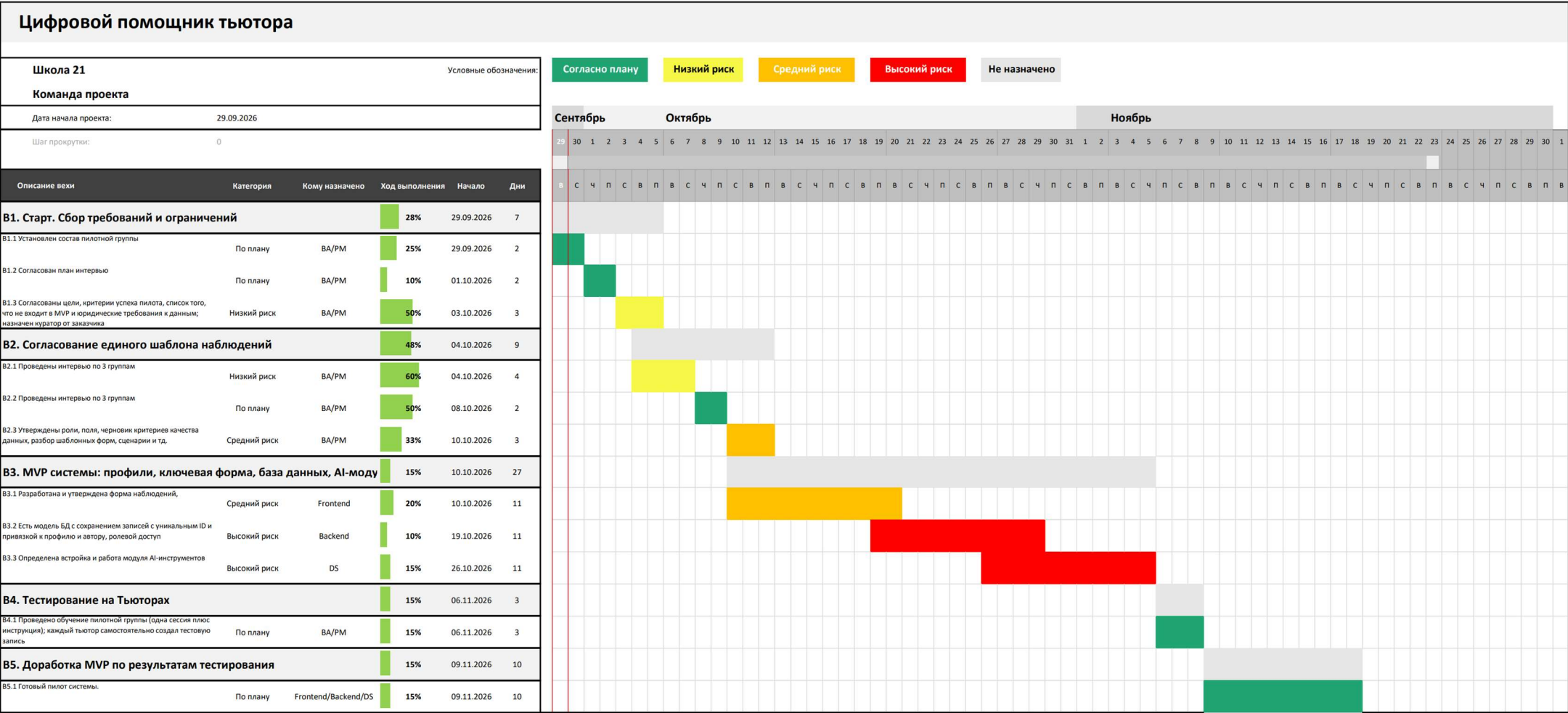
По итогам, например, — документированное решение заказчика о масштабировании или доработке.

Вехи пилота: сроки, критерии готовности, вовлечённые роли/участники

	Веха	Срок	Критерий готовности	Участник/роль
1	Старт. Сбор требований и ограничений	1 нед.	Установлен состав пилотной группы, согласован план интервью; согласованы цели, критерии успеха пилота, список того, что не входит в MVP, и юридические требования к данным; назначен куратор от заказчика	BA/PM, куратор заказчика.
2	Согласование единого шаблона наблюдений	1 нед.	Проведены интервью по всем шести группам вопросов (начало может быть в этапе 1). Утверждены роли, поля, значения шкал, исключения, правила исправления и черновик критериев качества данных, разбор шаблонных форм, словарь категорий и прототип шаблона; ключевые сценарии подтверждены пользователями.	Для интервью: все участники BA/PM, Frontend, Куратор заказчика
3	MVP системы: профили, ключевая форма, база данных, AI-модуль.	3-4 нед.	Разработана и утверждена форма наблюдений, есть модель БД с сохранением записей с уникальным ID и привязкой к профилю и автору, ролевой доступ; проверены на тестовых обезличенных данных. Безопасность хранения данных подтверждена. Определена встройка и работа модуля AI-инструментов	Ответственный за данные со стороны Заказчика, BA/PM, Frontend, Backend, DS
4	Тестирование на Тьюторах	0,5 нед.	Проведено обучение пилотной группы (одна сессия плюс инструкция); каждый тьютор самостоятельно создал тестовую запись; дефекты критического уровня закрыты, фиксация ошибок	Тьюторы, BA/PM
5	Доработка MVP по результатам тестирования	1,5 нед.	Готовый пилот системы. • Решение работает как веб-сервис и/или мобильное приложение, отрабатывает ключевые функции. • Реализованы интерфейсы специалиста, тьютора, родителя и врача с разграничением прав доступа. • Реализована единая форма фиксации наблюдений и результатов занятий. • Реализована визуализация динамики ребёнка (графики, цветовая индикация). • Реализован AI-анализ накопленных данных с формированием подсказок. • AI-выводы сопровождаются указанием данных, на которых они основаны. • Реализована возможность специалисту подтверждать, отклонять или корректировать AI-подсказки. • Обеспечена защита и разграничение доступа к данным ребёнка. • Продемонстрирован полный сценарий: внесение наблюдения → анализ → динамика → подсказка.	BA/PM, Frontend, Backend, DS

График пилота

Диаграмма показывает два пересечения, важных для срока. Разработка MVP (B3) стартует параллельно с уточнением шаблона (B2) — форма строится уже по согласованной структуре категорий. Разработка модели данных (B3.2) стартует до завершения утверждения и разработки форм наблюдений (B3.1), а подключение AI-аналитики (B3.3) могут идти приблизительно одновременно с предшествующими работами B3.1 и B3.2: подсказки обучаются и калибруются на живых данных, а не на тестовых заготовках, поэтому к вехе B7 команда получает проверенные на практике выводы.



Роли и ответственность

Команда пилота компактна и покрывает полный цикл: продукт, разработка, качество. Роли и их зоны ответственности перечислены ниже; ряд ролей могут совмещаться одним человеком — например, аналитик может так же частично брать на себя задачи QA. Ключевое требование — у каждой вехи есть один ответственный, а куратор со стороны заказчика имеет полномочия принимать решения в течение согласованного срока.

	Роль	Зона ответственности
1	PM/BA	Установлен состав пилотной группы, согласован план интервью; согласованы цели, критерии успеха пилота, план, риски, коммуникация с заказчиком, отчёты по вехам интервью, шаблон наблюдений, требования, гипотезы для AI-анализа
2	бэкенд и фронтенд	форма, база данных, профили, интеграция AI-модуля интерфейс формы и профиля, простота заполнения тест-планы, проверка валидации и ролевого доступа
5	Куратор со стороны заказчика	решения, доступ к пользователям, контроль юридических условий
6	Тьюторы-пилотеры (2–3)	ежедневный ввод, обратная связь по форме и нагрузке
7	Специалисты сопровождения	оценка подсказок, связь с ИОМ
8	Представители родителей (по согласию)	оценка понятности динамики и отчётов
9	Врач	требования к выгрузкам, интерпретация значимых изменений

Ключевые риски пилота и меры предупреждения

	Риск	Меры предупреждения
1	Низкая дисциплина ежедневного ввода: тьюторы перегружены и пропускают записи, данные становятся дырявыми или формальными.	Форма за 5–7 минут с выбором значений; обучение одной сессией и короткая инструкция; напоминания в удобный момент смены; еженедельная метрика заполнения на статусе с заказчиком; бумажный резерв в первую неделю с переносом данных
2	Нарушение режима персональных данных пациентов (152-ФЗ): утечка или доступ шире необходимого	Согласия родителей до старта (веха В1); ролевой доступ и журнал действий с первого релиза; обезличивание данных в AI-аналитике; обработка в контуре заказчика; проверка доступа QA на вехе В3. С самого начала закладывать анонимизацию тестовых данных на пилоте и explainability AI-подсказок, не давать AI делать медицинские выводы напрямую (только гипотезы для специалиста).
3	Недоверие к AI-подсказкам	Каждая подсказка содержит обоснование (исходные записи, логика связи, уровень уверенности), а решение всегда остаётся за человеком — это заложено в процесс раздела 4 и проверяется на вехе В4
4	За два месяца не накопится достаточно качественных наблюдений для надёжного AI-анализа.	Сразу согласовать минимальный объём и критерии качества данных; предусмотреть ответ «данных недостаточно» и показывать возможности анализа на разрешённом историческом либо синтетическом наборе, явно отделяя такую демонстрацию от результатов пилота.

Задача 4. Организация процесса работы.

Формат взаимодействия с заказчиком

Принцип коммуникации с заказчиком — фиксированный ритм и предсказуемое содержание: заказчик всегда знает, когда и о чём он услышит команду, а каждое сообщение заканчивается конкретным запросом — решение, информация или срок. Технические детали остаются внутри команды; на статусах обсуждаются ценность, риски и решения.

	Событие	Формат	Частота	Фокус сообщения
1	Статус-встреча	Онлайн, 30–45 минут	Еженедельно	Прогресс против плана вех, риски, blocked-вопросы, принятые решения
2	Демо инкремента	Онлайн, 30 минут	Раз в 2 недели	Работающий функционал на реальном сценарии, сбор обратной связи
3	Оперативный канал	Мессенджер, асинхронно	Ежедневно	Быстрые вопросы и блокеры; время ответа — до конца рабочего дня
4	Отчёт о пилоте*	Документ на одну страницу	Еженедельно в период пилота	Метрики заполнения, инциденты, инсайты недели, запрашиваемые решения (*по нагрузке)
5	Веховые встречи*	Очно или онлайн	По вехам	Цели и критерии вехи, промежуточные решения, границы следующего этапа (*по нагрузке)

Ритм работы команды разработки

Внутренний ритм команды строится вокруг короткого цикла «сделал — показал — получил обратную связь». Каналы разделены: обсуждение — в чате, задачи — в трекере, решения — в логе решений. Это исключает ситуацию, когда важное решение существует только в устной договорённости.

	Событие	Формат	Частота	Фокус сообщения
1	Ежедневный стендап	Онлайн, 15 минут	Ежедневно,	Что сделано, план на день, блокеры
2	Планирование недели	Онлайн, 60 минут	Еженедельно,	Приоритеты, ёмкость команды, зависимости между задачами
3	Ретроспектива	Онлайн, 45 минут	Раз в 2 недели,	Что улучшаем в процессе; 1–2 конкретных действия с ответственными
4	Внутреннее демо	Онлайн	Раз в 2 недели	Качество функционала до показа заказчику
	Трекер задач (канбан)	Онлайн	Постоянно	Статусы, приоритеты, определение готовности (Definition of Done)
5	Лог решений	Онлайн	По мере принятия решений	Контекст, рассмотренные варианты, выбор, ответственный, дата

Правила фиксации решений и эскалации

Единая система задач: любая договорённость, меняющая объём или срок, попадает в трекер в течение рабочего дня. Протокол любой встречи с заказчиком состоит из трёх блоков — решения, ответственные, сроки — и отправляется в течение суток. Блокер, не снятый за 24 часа, эскалируется руководителю проекта; конфликт требований между пользователями — куратору заказчика. Изменения требований фиксируются в бэклоге и оцениваются по влиянию на срок пилота: команда показывает заказчику цену изменения, а решение принимает заказчик.

Мотивация участия в проекте.

1	Почему тебе интересен этот проект?	Мне интересен этот проект, потому что здесь решается не абстрактная или выдуманная техническая задачу, а конкретная проблема, связанная с качеством сопровождения детей с ОВЗ. Для решения задачи предполагается применение разного своего функционала - здесь есть хороший баланс между бизнес-задачей (работа с заказчиком и пользователями), аналитикой и применением AI. Также интересно поучаствовать именно в создании реального продукта совместно с организацией-заказчиком. Хочется пройти весь реальный путь — от понимания потребности пользователей и формализации требований до проверки гипотез, создания MVP и получения обратной связи от настоящих пользователей. Мне было бы интересно помочь сделать такую систему действительно полезной, понятной и безопасной для пользователей.
2	Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?	В команде я вижу себя на стыке бизнес-аналитики и управления проектом — человеком, который помогает переводить потребности заказчика и пользователей в понятные для команды продукта задачи. В первую очередь я хотела бы заниматься исследованием потребностей: общаться с заказчиком и пользователями, выявлять реальные сценарии работы, фиксировать проблемы и формулировать требования, что бы потом структурировать их. В части управления проектом я готова помогать синхронизировать участников, следить за договорённостями, сроками и результатами. При этом я не хочу быть мажорным постановщиком задач. Мне интересно погружаться в предметную область, изучать в возможностях AI, работать вместе с разработчиками и при необходимости брать на себя задачи за пределами своей основной зоны ответственности, думаю, что могу справиться с задачами, связанными с визуальным восприятием интерфейса, так как у меня есть опыт работы архитектором за границами SCHOOL21.
3	Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?	35-40 часов, начиная ~с 25 октября, так как на текущий момент не имею постоянной работы.